TAL-06 · Talento, educación y tech sectorial

Ley que fortalece la historia clínica electrónica interoperable y establece plazos y estándares obligatorios para el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas

Modifica la Ley 30024 para fijar plazos obligatorios de adopción de historia clínica electrónica en todos los subsistemas de salud, adoptar estándares abiertos de interoperabilidad (HL7 FHIR), garantizar el acceso del paciente a su información y crear un tablero público de avance.

Comisión (Cámara de Diputados): Salud (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano
Plan Perú 2050: Salud, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

La Ley 30024 creó en 2013 el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE); fue modificada por el Decreto Legislativo 1306 y por la Ley 31750 (2023), que redefinió el RENHICE como infraestructura tecnológica de respaldo que utiliza la Plataforma Nacional de Interoperabilidad y habilitó el acceso a información disociada con fines de investigación. En 2025 el Minsa aprobó, mediante la Resolución Ministerial 164-2025/MINSA, una directiva para la acreditación de los sistemas de información de historias clínicas electrónicas. Sin embargo, la ley no fija plazos obligatorios para que los establecimientos del Minsa, gobiernos regionales, EsSalud, sanidades y privados adopten historias clínicas electrónicas interoperables, ni determina un estándar técnico abierto de intercambio, ni obliga a publicar el avance. En la práctica, coexisten sistemas no interoperables y registros en papel, lo que provoca duplicidad de exámenes, pérdida de información al derivar pacientes y dificulta la continuidad de la atención. El Plan Perú 2050 (Salud) propone infraestructura de datos con estándar HL7 FHIR integrada a la HCE nacional.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE FORTALECE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA INTEROPERABLE Y ESTABLECE PLAZOS Y ESTÁNDARES OBLIGATORIOS PARA EL REGISTRO NACIONAL DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto fortalecer la implementación de la historia clínica electrónica interoperable en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del país, públicos, privados y mixtos, modificando e incorporando disposiciones a la Ley 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas.

Artículo 2. Incorporación del artículo 4-A a la Ley 30024

Incorpórase el artículo 4-A a la Ley 30024, con el siguiente texto: "Artículo 4-A. Estándares de interoperabilidad. 4-A.1 El Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector, aprueba y actualiza los estándares técnicos de interoperabilidad de la historia clínica electrónica, priorizando estándares abiertos internacionales como HL7 FHIR y terminologías clínicas reconocidas. 4-A.2 Los sistemas de información de historias clínicas electrónicas que se adquieran, desarrollen o renueven a partir de la vigencia de la presente disposición cumplen dichos estándares como requisito para su acreditación."

Artículo 3. Plazos de adopción

3.1 Los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención de todos los subsistemas implementan historia clínica electrónica acreditada e interoperable con el RENHICE en un plazo no mayor de tres años desde la entrada en vigor del reglamento. 3.2 Los establecimientos del primer nivel lo hacen de manera progresiva en un plazo no mayor de cinco años, priorizando aquellos con conectividad. 3.3 En los establecimientos sin conectividad se admiten soluciones de registro que permitan sincronización diferida.

Artículo 4. Acceso del paciente

Toda persona tiene derecho a acceder gratuitamente, por medios digitales, a su información clínica resumida registrada en el RENHICE, a conocer qué profesionales o establecimientos accedieron a ella y a descargarla en un formato estructurado y legible, conforme a la Ley 29733.

Artículo 5. Solución pública de historia clínica electrónica

El Ministerio de Salud pone a disposición de los establecimientos públicos, sin costo de licencia, una solución de historia clínica electrónica acreditada y de código abierto o de propiedad del Estado, que pueda ser adoptada por los gobiernos regionales.

Artículo 6. Seguridad de la información

Los sistemas de historia clínica electrónica cumplen con medidas de seguridad, registro de accesos y trazabilidad, y se sujetan a las restricciones de uso establecidas en el artículo 3 de la Ley 31750 y a la Ley 29733.

Artículo 7. Tablero público de avance

El Ministerio de Salud publica trimestralmente en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos un tablero con el número y porcentaje de establecimientos con historia clínica electrónica acreditada e interoperable, desagregado por subsistema, región y nivel de atención.

Artículo 8. Formación del personal de salud

El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales incorporan en sus planes de desarrollo de las personas la capacitación del personal de salud en el uso de la historia clínica electrónica y en informática en salud.

Artículo 9. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales del Ministerio de Salud, EsSalud, los gobiernos regionales y demás entidades involucradas, de manera progresiva y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Adecuación reglamentaria. El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la Ley 30024 a lo dispuesto en la presente ley en un plazo de noventa días hábiles, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Salud.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Informe anual. El Ministerio de Salud informa anualmente a la comisión ordinaria competente en materia de salud sobre el cumplimiento de los plazos del artículo 3.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Articulación con el sector privado. La Superintendencia Nacional de Salud supervisa el cumplimiento de los plazos de adopción por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y mixtas, en el marco de sus competencias.

III. Análisis costo-beneficio

La ley no crea partidas: ordena plazos y estándares que las entidades cumplen con presupuestos institucionales de forma progresiva (art. 79). La solución pública sin costo de licencia reduce el gasto de gobiernos regionales frente a adquisiciones fragmentadas. Los costos principales son equipamiento, conectividad de establecimientos y capacitación. Los beneficios incluyen menor duplicidad de pruebas diagnósticas, continuidad de la atención en referencias y contrarreferencias, reducción de errores de medicación, mejores datos para la gestión sanitaria y la investigación (ya habilitada por la Ley 31750) y bases para servicios avanzados como telesalud y gemelos digitales. El riesgo de seguridad se mitiga con trazabilidad de accesos.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 30024 (incorpora el artículo 4-A) y complementa la Ley 31750, la Ley 26842 y la Ley 29733.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de establecimientos de segundo y tercer nivel y al menos el 60% del primer nivel cuentan con historia clínica electrónica acreditada e interoperable con el RENHICE, según el tablero público del Minsa.

Normas relacionadas

• Ley 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30024.pdf

• Ley 31750, Ley que modifica los artículos 2 y 4 de la Ley 30024 (interoperabilidad de HCE e investigación con datos disociados) — https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31750-TXM.pdf

• Resolución Ministerial 164-2025/MINSA, Directiva de acreditación de los Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2378748-1

• Ley 26842, Ley General de Salud — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26842.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

La Ley 31750 (publicada el 24-05-2023) modificó los artículos 2 y 4 de la Ley 30024. Otros proyectos del periodo 2021-2026: por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Colombia: Ley 2015 de 2020, que crea la historia clínica electrónica interoperable — https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=105472

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2025/327 relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj

Fuentes

• Congreso: Modifican ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas — https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/modifican-ley-que-crea-el-registro-nacional-de-historias-clinicas-electronicas

• HL7 FHIR, especificación vigente — https://www.hl7.org/fhir/

• OMS: Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025 — https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-06.html